

CAPÍTULO 14.17

Esclerodermia

PERFIL EUNACOM 1.14.17
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **Esclerodermia** o **Esclerosis Sistémica (ES)** es una enfermedad autoinmune multisistémica caracterizada por una tríada fisiopatológica: daño vascular, activación del sistema inmune y fibrosis progresiva de la piel y órganos internos.

Se clasifica fundamentalmente en dos grandes formas clínicas: la **Esclerosis Sistémica Limitada** y la **Esclerosis Sistémica Difusa**.

1. Esclerosis Sistémica Limitada (Síndrome de CREST)

Representa aproximadamente el 70% de los casos. Se caracteriza por un compromiso cutáneo que se limita a las zonas distales de las extremidades (dedos, manos) y la cara.

El acrónimo **CREST** describe sus manifestaciones cardinales:

- **C - Calcinosis:** Depósitos de calcio en los tejidos blandos, frecuentemente en los dedos.
- **R - Fenómeno de Raynaud:** Isquemia digital episódica en respuesta al frío o estrés. Es el síntoma inicial más frecuente y suele preceder por años al resto de la clínica.
- **E - Esfágica (Disfunción):** Atrofia muscular de los 2/3 inferiores del esófago, lo que genera una **disfagia ilógica** (similar a la **Acalasia**) y pirosis intensa por reflujo gastroesofágico.
- **S - Esclerodactilia:** Engrosamiento y endurecimiento de la piel de los dedos. Es el signo que suele definir el diagnóstico clínico.
- **T - Telangiectasias:** Dilataciones vasculares que aparecen en cara, labios y manos.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: En el CREST, el **Fenómeno de Raynaud** aparece años antes que el compromiso cutáneo. Si un Raynaud es muy intenso, persistente y progresivo, siempre se debe sospechar una esclerodermia subyacente.

2. Esclerosis Sistémica Difusa

En esta variante, la esclerosis cutánea progresa rápidamente y no se limita a las manos y cara, sino que afecta también **antebrazos, brazos, tronco y abdomen**.

- El Fenómeno de Raynaud suele aparecer simultáneamente o poco después del inicio de los cambios en la piel.
- Tiene un mayor riesgo de **compromiso visceral precoz** (pulmones, corazón, riñones).
- La afectación de la piel es más severa y puede llevar a una pérdida marcada de la movilidad.

3. Comparativa y Marcadores Serológicos

El diagnóstico se apoya en la presencia de anticuerpos específicos que, además, tienen valor pronóstico.

TABLA 14.17.1: CARACTERÍSTICA VS ES LIMITADA (CREST)		
CARACTERÍSTICA	ES LIMITADA (CREST)	ES DIFUSA
Extensión de piel	Dedos, manos, cara ("Cara de pájaro")	Generalizada (incluye tronco y extremidades proximales)
Anticuerpo ANA	Patrón Anticentrómero	Patrón Antinucleolar
Anticuerpos específicos	Anticentrómero	Anti-Scl-70 (Anti-topoisomerasa I) y Anti-ARN polimerasa III
Compromiso Pulmonar	Hipertensión Pulmonar (tardía)	Fibrosis Pulmonar (precoz)
Crisis Renal	Poco frecuente	Más frecuente y grave

NOTA CLÍNICA
Fisiopatología: La esclerosis cutánea produce la "cara de pájaro" o "facies esclerodérmica", caracterizada por nariz afilada, labios finos y microstomía (apertura bucal limitada) con surcos peribucales radiados.

4. Complicaciones Orgánicas Graves

Las complicaciones pulmonares son actualmente la principal causa de mortalidad en estos pacientes.

Compromiso Pulmonar

1. **Fibrosis Pulmonar (Enfermedad Pulmonar Intersticial):** Es la manifestación más frecuente de la **ES Difusa**. Se presenta con disnea de esfuerzos y tos seca.

2. **Hipertensión Pulmonar (HTP):** Es la complicación clásica de la **ES Limitada (CREST)**. Suele ser de tipo precapilar por vasculopatía proliferativa.

Crisis Renal Esclerodérmica

Es una emergencia médica caracterizada por la aparición brusca de **hipertensión arterial maligna** e **Insuficiencia Renal Aguda**.

- Se asocia frecuentemente a la presencia del anticuerpo **Anti-ARN polimerasa 3**.
- Se manifiesta por cefalea, visión borrosa y deterioro de la función renal.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

¡Cuidado! El tratamiento de la crisis renal esclerodérmica **NO es con corticoides**. De hecho, dosis altas de corticoides (>15 mg de prednisona) pueden gatillar la crisis. El tratamiento de elección son los **IECA** (Enalapril, Captopril), incluso si hay falla renal.

5. Diagnóstico y Tratamiento

El diagnóstico es fundamentalmente **clínico**, basado en la esclerosis cutánea y el fenómeno de Raynaud, apoyado por la capilaroscopia y la serología.

Manejo Inicial

No existe un tratamiento curativo que revierta la enfermedad, por lo que el manejo es sintomático y órgano-específico:

- **Fenómeno de Raynaud:** Medidas físicas (evitar frío) y fármacos vasodilatadores, siendo los **Calcioantagonistas** (como el **Amlodipino**) la primera línea.
- **Disfunción Esofágica:** Medidas antirreflujo y uso crónico de Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP).
- **Inmunomoduladores:** Se utilizan inmunosupresores (como el Micofenolato o Ciclofosfamida) especialmente en casos de fibrosis pulmonar activa, aunque la evidencia suele ser moderada.
- **Crisis Renal:** Uso mandatorio de **IECA**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para recordar el anticuerpo del CREST: **"Anti-CREST-ómero"** (Anticentrómero).

6. Signos Clínicos de Alarma

Durante el examen físico y seguimiento, se debe vigilar:

- **Yemas de los dedos:** La isquemia crítica por Raynaud puede causar úlceras digitales, necrosis y pérdida de falanges.
- **Piel brillante y tensa:** Indica fase edematosa o indurativa activa.
- **Pérdida de anexos:** Desaparición de vellos y glándulas sudoríparas en las zonas afectadas.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente con fenómeno de Raynaud, esclerodactilia, disfagia y telangiectasias faciales. Los anticuerpos antinucleares muestran patrón anticentrómero. ¿Cuál es el diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Esclerodermia. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- CREST: Calcinosis, Raynaud, Esófago, eSclerodactilia, Telangiectasias; Raynaud es el síntoma inicial, esclerodactilia define el diagnóstico
- Esclerodermia difusa: esclerosis cutánea extendida más allá de manos y cara, con afectación de órganos internos
- Complicación pulmonar del CREST: hipertensión pulmonar; de la difusa: fibrosis pulmonar
- Crisis renal esclerodérmica se maneja con IECA, no con corticoides
- Marcadores: anticentrómero (CREST), anti-SCL70 y antinucleolar (difusa)
- Anti-ARN polimerasa 3 se asocia a formas más graves de esclerodermia difusa
- Diagnóstico clínico: fenómeno de Raynaud + esclerosis de los dedos son los puntos cardinales

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ESCLERODERMIA)**PREGUNTA 1**

Paciente con fenómeno de Raynaud, esclerodactilia, disfagia y telangiectasias faciales. Los anticuerpos antinucleares muestran patrón anticentrómero. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Esclerodermia difusa
- B)** Lupus eritematoso sistémico
- C)** Esclerodermia limitada (CREST)
- D)** Enfermedad mixta del tejido conectivo
- E)** Síndrome de Sjögren

PREGUNTA 2

Paciente con esclerodermia difusa presenta insuficiencia renal aguda grave. ¿Cuál es el manejo de primera línea?

- A)** Corticoides endovenosos
- B)** Ciclofosfamida
- C)** IECA
- D)** Rituximab
- E)** Plasmaféresis

PREGUNTA 3

¿Cuál es la complicación pulmonar más frecuente de la esclerodermia limitada (CREST)?

- A)** Fibrosis pulmonar
- B)** Hipertensión pulmonar
- C)** Alveolitis hemorrágica
- D)** Derrame pleural
- E)** Tromboembolismo pulmonar

RESUMEN: ESCLERODERMIA

La esclerodermia (esclerosis sistémica) se clasifica en dos formas: limitada (CREST) y difusa. El CREST es un acrónimo que incluye calcinosis de los dedos, fenómeno de Raynaud (síntoma más frecuente e inicial), compromiso esofágico (disfagia ilógica y pirosis), esclerodactilia (esclerosis de la piel de los dedos, signo clínico que suele definir el diagnóstico) y telangiectasias (cara y zonas de esclerosis). El CREST también afecta la piel de la cara con la famosa cara de pájaro. La esclerodermia difusa puede tener la misma clínica que el CREST, pero la esclerosis cutánea se extiende más allá de dedos, manos y cara, alcanzando antebrazos y resto del cuerpo, y afecta otros órganos (pulmones, corazón, riñones). La fibrosis pulmonar es la complicación más frecuente de la difusa, mientras que la hipertensión pulmonar lo es del CREST. La crisis renal esclerodérmica es una urgencia que se maneja con IECA (no corticoides). Los marcadores son: anticentrómero (CREST) y anti-SCL70/antinucleolar/anti-ARN polimerasa 3 (difusa). El tratamiento es sintomático (amlodipino para Raynaud) más inmunomoduladores.